

BRIEF DZIENNIKARSKI — Lex Szarlatan jako produkt sieci instytucjonalnej

Status dokumentu: Roboczy, do dystrybucji dla zaufanych dziennikarzy. **Data:** 15 maja 2026 **Autor:** Koordynator pakietu stanowiska obywatelskiego ws. UD207

Adresaci docelowi (sugestia):

- Rzeczpospolita — sekcja Plus Minus (śledczo-analityczna) lub Prawo
- OKO.press — sekcja prawo / zdrowie
- Gazeta Wyborcza Magazyn (śledztwo wielowątkowe)
- Polityka — sekcja Społeczeństwo
- Onet — sekcja Wiadomości / Zdrowie
- Wyborcza.biz — kontekst pharma

Format: materiał śledczy wielowątkowy, długość docelowa 8–12 stron drukowanych. Możliwy podział na cykl 3 artykułów.

TEZA WIODĄCA

Projekt ustawy „lex szarlatan” (UD207, przyjęty przez Radę Ministrów 12 maja 2026 r.), przedstawiany przez rząd jako odpowiedź na społeczne oczekiwanie ochrony pacjentów, w świetle publicznie dostępnych dokumentów jawi się jako rozwiązanie wypracowane w kręgu instytucjonalnym, w którym regulator (Rzecznik Praw Pacjenta), eksperci doradczy z udokumentowanymi powiązaniami z przemysłem farmaceutycznym oraz organizacje pacjenckie korzystające z finansowania tych samych firm — wspólnie kształtują jego treść. Mechanizm represji wobec praktyk integracyjnych w onkologii działa już dziś: Sąd Najwyższy w grudniu 2025 r. uznał jego konkretne zastosowanie wobec lekarza specjalisty za rażące naruszenie prawa do obrony. Projekt UD207 — w art. 64a — odzwierciedla na poziomie ustawy ten sam schemat proceduralny, który SN uznał za niedopuszczalny.

KLUCZOWE FAKTY DO ARTYKUŁU (zweryfikowalne, z atrybucją)

1. Regulator pisze własną ustawę

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec (urząd od 30.10.2017, druga 5-letnia kadencja od II 2022, powołany dwukrotnie za rządów PiS) jest **inicjatorem projektu UD207**, który **rozszerza jego własne uprawnienia o sankcje administracyjne do 1 mln zł**, decyzje tymczasowe z natychmiastową wykonalnością oraz publiczne ostrzeżenia przed zakończeniem postępowania.

W wywiadzie dla „Menedżera Zdrowia” z 21 stycznia 2025 r. (Termedia, rozmówca Krystian Lurka) Chmielowiec deklaruje wprost:

- „W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta — wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia — przygotowujemy projekt ustawy. Chodzi o **rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta**”
- „Skuteczność mojego działania podniosłyby uprawnienia, takie jakie mają prezesi UOKiK, UKE i UODO — oni mogą nakładać kary, ja nie”
- „pracownicy Biura RPP będą mogli zażądać dowodów na skuteczność tej czy innej metody pseudoleczenia. **Jeśli takich dowodów nie będzie, będę mógł zakazać jej stosowania i nałożyć karę**”
- „Twierdzę, że gdybym miał narzędzia, o których mówiłem, to w ciągu roku skutecznie zablokowałbym szerzenie się udzielania pseudomedycznych świadczeń”

Chmielowiec wymienia z nazwy jako „pseudoleczenie”: wlewy z witaminy C, kurkuminy, ozonoterapię w nowotworach, DMSO, „leczenie laptopem”.

2. Skład Rady Ekspertów RPP — dobór pod agendę

Rada Ekspertów przy RPP (34 osoby, charakter opiniotwórczo-doradczy) została **częściowo zaktualizowana w 2026 r. — bezpośrednio przed wniesieniem projektu UD207**. Z Rady odeszli m.in. prof. Mariusz Frączek, prof. Wiesław Jędrzejczak (hematolog/onkolog o bardziej zrównoważonym profilu), prof. Maria Barcikowska-Kotowicz. Dokooptowano m.in.:

— **prof. Marcin Czech** — były wiceminister zdrowia za rządów PiS. W trzech recenzowanych publikacjach 2024–2025 deklaruje konsultacje/doradztwo dla **15 firm farmaceutycznych jednocześnie**: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Biogen, Eli Lilly, GSK, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi, Servier, Takeda, UCB (źródło: artykuł „Improving Vaccine Assessment Pathways” PMC10975328, Frontiers in Public Health 2024). W kolejnej publikacji ujawnia bezpośrednie finansowanie badania przez **Merck Sharp & Dohme** (PMC12714914, DOI 10.3389/fpubh.2025.1682169). W trzeciej — honoraria Advisory Board od **Sanofi i AstraZeneca** (Viruses 2025, DOI 10.3390/v18010060).

— **prof. Bolesław Samoliński** — przewodniczący Rady Ekspertów. W publikacji w czasopiśmie z grupy Allergy (ScienceDirect 2025, artykuł S2213219825005355) deklaruje dosłownie: „Samoliński reports personal fees from Polpharma, TEVA, **patient ombudsman**, Polish Allergology Society, Viatrix, and ADAMED”. „**Patient ombudsman**” **oznacza Rzecznika Praw Pacjenta** — przewodniczący Rady Ekspertów RPP pobiera honoraria osobiście od RPP, czyli organu, którego decyzje ma niezależnie opiniować. **To smoking gun bezpośredniej zależności finansowej eksperta od regulatora.**

— **prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska** (UMCS Lublin), dokooptowana 27.05.2025 do zespołu roboczego ds. dezinformacji medycznej. **30 października 2025 r. — dzień po wyroku WSA dotyczącym podmiotu leczniczego stosującego wlewy witaminy C, kurkuminy i salinomycyny** — opublikowała na koncie X (status 1983941226547065300): „To był podmiot leczniczy, więc @RzeczPacjenta mógł

zareagować. A co w przypadku, gdy »cudowne« leczenie proponują szarlatani? **Tutaj jest potrzebny Lex Szarlatan – nowe narzędzie do obrony praw pacjenta**". Wpis członkini Rady Ekspertów RPP, wzywający do uchwalenia ustawy w bezpośrednim kontekście konkretnej sprawy zakończonej karą administracyjną — w której to ciało doradcze potencjalnie opiniowało.

3. Mapa pharma-conference circuit

9 października 2025 r. konferencja INFARMA „(NIE) RÓWNOŚĆ w dostępie do zdrowia – jak stawić czoła barierom i wykluczeniu" (Forum, Warszawa).

Partnerzy merytoryczni: AstraZeneca, Merck, MSD, Bayer, Roche.

Prelegenci i moderatorzy:

- Panel II (Edukacja): Ekspert 2 — **prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska** (członkini Rady Ekspertów RPP); moderator: **Joanna Krych, Medical Affairs Manager Vaccines MSD**
- Panel III (Doświadczenie pacjenckie): uczestniczka — **Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze RPP, opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy RPP**; moderator: **Jacek Migdał, Medical Science Expert Merck**
- W konferencji uczestniczyły także: **Magdalena Kołodziej (Fundacja MY PACJENCI — członkini Rady Ekspertów RPP)**; **Joanna Frątczak-Kazana (Fundacja ALIVIA — członkini Rady Ekspertów RPP)**

Inne konferencje INFARMA z udziałem członków Rady Ekspertów RPP:

- 27.05.2026: „Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy" — **prof. Marcin Czech prowadzi sesję z Michałem Byliniakiem, dyrektorem INFARMA**
- X Krakowskie Sympozjum HTA 2024 (certyfikat INFARMA): prof. Czech prowadzi dwa panele
 - n. i 16. Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 2022 i 2024 (certyfikaty INFARMA): **prof. Bolesław Samoliński — przewodniczący/współprzewodniczący**
- Top Medical Trends 2026 (certyfikat INFARMA): **prof. Jacek Wysocki — Przewodniczący Komitetu Naukowego** (członek Rady Ekspertów RPP, były prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych — instytucji, której materiały RPP wykorzystywał w postępowaniach przeciw podmiotom leczniczym).

4. Pharma-finansowanie organizacji pacjenckich — astroturfing udokumentowany naukowo

Recenzowana publikacja: **Makowska M., Mulinari S., Ozieranski P.** „Pharmaceutical Industry Payments to Patient Organizations in Poland: Analysis of the Patterns, Evolution, and Structure of Connections", International Journal of Social Determinants of Health and Health Services, 2025; 55(2):199–212. DOI: 10.1177/27551938241305995; PMID **39726201**; pełny tekst **PMC11977834**.

Najważniejsze ustalenia (lata 2012–2020):

- 33 firmy farmaceutyczne wypłaciły organizacjom pacjenckim w Polsce **€13 729 644** łącznie
- **273 organizacje** pacjenckie były beneficjentami
- **37,5% wszystkich środków (€5 151 699) trafiło do organizacji onkologicznych**
- 53,8% organizacji (147 z 273) miało tylko jednego darczyńcę-firmę pharma (wskaźnik strukturalnej zależności)
- **Roche** był łącznym top donatorem 2012–2020: **€1 989 651, 531 płatności do 101 organizacji** pacjenckich
- 10 firm raportujących we wszystkich 9 latach: Amgen, AstraZeneca, Biogen, Chiesi, GSK, Merck, Janssen-Cilag, Pfizer, **Roche**, Takeda

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (KRS 0000333981, prezes Elżbieta Markowska, 47 organizacji członkowskich, siedziba Warszawa) była — wg artykułu — **najbardziej połączoną organizacją w całej sieci, z połączeniami do 21 firm farmaceutycznych.**

5. Sieć komunikacji wokół projektu

Onkofundacja ALIVIA w artykule opublikowanym 10 marca 2025 r. zadeklarowała:

„Jako Fundacja Alivia w pełni popieramy wzmocnienie roli Rzecznika Praw Pacjenta i jego walkę z pseudomedycyną. To ważny krok w kierunku ochrony chorych przed manipulacją i dezinformacją. Wspieramy wszelkie działania zmierzające do eliminacji pseudoterapii i ostrzegamy pacjentów przed korzystaniem z niesprawdzonych metod leczenia. **Jeśli spotkaliście się z podejrzanymi ofertami terapeutycznymi, zgłóście je do Rzecznika Praw Pacjenta.**”

Źródło: alivia.org.pl/aktualnosci/pseudomedycyna-pod-lupa-surowe-kary-dla-oszustow-zerujacych-na-chorych/ z 10.03.2025

Stanowisko nie zawiera żadnej oceny proporcjonalności, żadnej krytyki gwarancji proceduralnych. **Aktywnie zachęca pacjentów do donoszeń do Rzecznika** — czyli organu, którego rozszerzenie kompetencji wspiera. Wicedyrektorka Alivia **Joanna Frątczak-Kazana** jest jednocześnie **członkinią Rady Ekspertów RPP**, opiniującej ten sam projekt.

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (prezeska Dorota Korycińska, członkini Rady Ekspertów RPP) wraz z ALIVIĄ wydały wspólne stanowisko „w sprawie niebezpiecznych praktyk pseudoterapeutycznych w onkologii”.

6. Wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2025 r. — empiryczny dowód systemowego problemu

W grudniu 2025 r. (publiczne ogłoszenie 7–8.12.2025) Sąd Najwyższy uwzględnił w całości kasację wniesioną w imieniu lekarza specjalisty stosującego terapie wspomagające w onkologii, od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z 9.01.2025 r. (roczne zawieszenie prawa wykonywania zawodu). SN **uchylił orzeczenie NSL i umorzył całe postępowanie**, ostatecznie kończąc sprawę.

Pięć uchybień proceduralnych podniesionych w kasacji (z oświadczenia samego lekarza, YouTube 13.03.2025):

1. Odmówiono prawa do obrony
2. Wykluczono jawność rozprawy
3. Usunięto jednego z obrońców
4. Nie udostępniono protokołu z rozprawy
5. Zmieniono wcześniejszy wyrok nagany na roczne zawieszenie bez wyjaśnienia

SN uznał te uchybienia za rażące w postępowaniu, w którym **formalnie istniały** gwarancje proceduralne (prawo do obrony, jawność rozprawy, prawo do obecności obrońcy). Projekt UD207 — w art. 64a — **wyłącza analogiczne gwarancje na poziomie ustawy** jako normę systemową.

7. Statystyki organu, który walczy z „pseudomedycyną”

Rzecznik Praw Pacjenta w corocznych sprawozdaniach **nie prowadzi odrębnej statystyki spraw dotyczących pseudomedycyny**. Sprawozdanie za 2024 r.

(gov.pl/attachment/c82a420a) zawiera tabelę chronologiczną postępowań w sprawach naruszenia zbiorowych praw pacjentów — wzrost z 78 (2019) do 417 (2024), wszystkie dotyczą całokształtu spraw zbiorowych (NFZ, dostępność, podmioty lecznicze).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia w komunikacie 17.06.2025 (gov.pl) szacuje liczbę podmiotów pseudomedycznych w Polsce na „od kilku do kilkunastu tysięcy” — rozpiętość obejmująca rząd wielkości. **Ustawa z karami 1 mln zł projektowana jest bez empirycznego udokumentowania skali zjawiska** przez organ wykonawczy.

STRUKTURA PROPONOWANA — wariant artykułu (lub cyklu trzech)

Artykuł 1: „Regulator pisze własną ustawę” (śledztwo o Chmielowcu i Radzie)

- Wstęp: Czym jest UD207 i jaką drogę przeszła
- Chmielowiec jako inicjator: cytaty z wywiadu Termedia
- Rada Ekspertów: Czech (15 firm), Samoliński (honoraria od RPP), Szuster-Ciesielska (tweet 30.10.2025)
- Co znaczy „regulator-jako-autor” w teorii konstytucyjnej

Artykuł 2: „Pieniądze z farmacji w głos pacjentów” (śledztwo o astroturfingu)

- Wprowadzenie: czym jest astroturfing
- Artykuł Makowska et al. PMC11977834: liczby, organizacje, struktura
- Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych: prezes, 21 firm, 47 organizacji
- ALIVIA, OFO: ich stanowiska wobec UD207
- Frątczak-Kazana, Korycińska, Kołodziej w Radzie Ekspertów RPP
- Konferencja INFARMA DEI 9.10.2025: zamknięty krąg

Artykuł 3: „Wyrok Sądu Najwyższego, którego nikt nie zauważył” (śledztwo o sprawie Szalusia)

- Sprawa NSL: zawieszenie z 9.01.2025
- Wyrok WSA: 245 tys. zł kary
- Wygrana SN: pięć uchybień proceduralnych
- Co to znaczy dla UD207 — paralela konstytucyjna
- Personalna agenda Szuster-Ciesielskiej: tweet 30.10.2025
- Wyrok jako precedens — dlaczego pomimo niego ustawa idzie do Sejmu

Artykuł 4: „Lex szarlatan — krytyka nie z marginesu, tylko z głównego nurtu pracodawców”

Stanowisko z lipca 2025 r. siedmiu organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia — Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i cztery inne — podnosi te same zarzuty konstytucyjne wobec UD207, które prezentuje pakiet obywatelski.

Kluczowe stwierdzenia:

- art. 64a ust. 3 (rygor natychmiastowej wykonalności) „absolutnie nieakceptowalny”;
- art. 64a ust. 4 (wyłączenie art. 10 i 81 KPA) „rażące naruszenie KPA”;
- art. 67zj „zbyt szeroka, nieprzewidywalna definicja”;
- art. 67zl ust. 4 — odwrócenie ciężaru dowodu jako samodzielny zarzut.

Wniosek dla dziennikarza: argumenty pakietu obywatelskiego nie są radykalne — są podzielane przez mainstream instytucjonalny strony pracodawców. Tezę o „marginesowych obawach” trzeba odrzucić. Źródło: pracodawcydlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf

Artykuł 5: „OSR projektu UD207 — uzasadnienie bez liczb”

OSR projektu nie zawiera szacowanej liczby „pseudomedyków” w Polsce, danych o skali finansowej zjawiska, liczby pacjentów poszkodowanych ani analizy skuteczności istniejących instrumentów prawnych (art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry, art. 286 k.k., UOKiK / ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych, sądy lekarskie). To narusza art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów i zasadę przyzwoitej legislacji z art. 2 Konstytucji RP. Autonomiczna wada proceduralna — niezależna od merytorycznych.

Artykuł 7: „Arbitralność geograficzna — paradoks salinomycyny”

W piśmiennictwie naukowym udokumentowano pilotażowe zastosowanie kliniczne salinomycyny u ludzi — Naujokat C., Steinhart R., „*Salinomycin as a Drug for Targeting Human Cancer Stem Cells*”, BioMed Research International 2012;2012:950658, DOI 10.1155/2012/950658 (PubMed: 23251084) — w tym przypadek 40-letniej pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi opornym na chemioterapię. Kliniki medycyny biologicznej w krajach niemieckojęzycznych (jak Paracelsus Klinik Lustmühle w Szwajcarii) prowadzą terapie eksperymentalne i komplementarne w onkologii. Podstawa prawna: **compassionate use** (art. 83 rozp. 726/2004 — ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compassionate-use) lub **named-patient basis** (art. 5 ust.

1 dyrektywy 2001/83/WE) — mechanizmy prawa UE wprost dopuszczone dla pacjentów z chorobami poważnymi.

W Polsce ta sama praktyka jest dopuszczalna na podstawie art. 4 ustawy o zawodach lekarza (autonomia terapeutyczna potwierdzona wyrokiem SN z 10.02.2010 r.) oraz art. 37 Prawa farmaceutycznego (off-label).

Po wejściu UD207 publiczna wypowiedź polskiego lekarza o salinomycynie (wpis naukowy, prezentacja konferencyjna, wyjaśnienie pacjentowi) może zostać zakwalifikowana jako „praktyka pseudomedyczna” wg art. 67zj — z karą 1 mln zł.

Wniosek dla dziennikarza: pakiet pokazuje, że ta sama praktyka terapeutyczna o tej samej podstawie naukowej staje się legalna lub karalna w zależności od państwa członkowskiego UE. To rodzi ryzyko kolizji z art. 56 TFUE i art. 4 ust. 3 TUE. Argument szczególnie istotny w kontekście onkologii eksperymentalnej i pacjentów z zaawansowanymi nowotworami.

Artykuł 6: „Polska i Niemcy — paradoks Konwencji z Oviedo”

Polska razem z Niemcami, Belgią, Holandią, Wielką Brytanią, Włochami, Austrią i Szwajcarią NIE ratyfikowała Konwencji z Oviedo (29 państw europejskich ratyfikowało). Niemcy mimo braku ratyfikacji utrzymują system Heilpraktiker — proporcjonalną, pozytywną regulację CAM od 17.02.1939 r. (ok. 50 tys. specjalistów). Na tle wybranych systemów europejskich, zwłaszcza niemieckiego modelu Heilpraktiker, projekt UD207 wybiera model wyraźnie bardziej represyjny niż regulacyjny. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1206 (1999) zaleca **regulację, a nie zakaz** medycyny komplementarnej.

TABELA PORÓWNAWCZA — pięć reżimów represyjnych

Argument proporcjonalności: UD207 nie wypełnia luki, tworzy piąty reżim represyjny dla zachowań już penalizowanych.

Zachowanie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień

Eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwoleń

Oszustwo medyczne

Nieuczciwa praktyka rynkowa

Naruszenie standardów zawodowych

Pseudom